

ハラスメント対応マニュアル

対象：患者・家族等からのハラスメント行為

暴言・暴力・セクハラ・不当要求・長時間拘束等

（認知症・せん妄状態の患者からの危険行為も含む）

▶発生時の対応

- ① 職員の安全を優先し、加害者から一定の距離をとる（退室・逃げる）。
- ② 応援を呼ぶ（一人では対応しない。）
- ③ 自傷・物損の危険性がある場合でも興奮状態の場合は、声掛けのみ行う。
 - ・正面から話しかけない。
 - ・興奮状態の時は無理に行動を制止しない。
- ④ 主治医、上司等への連絡。
- ⑤ 怪我をした場合は、外来を受診する。外傷は写真を撮り、記録として残す。
- ⑥ 被害を受けたスタッフを、状況に応じて、勤務から外すことも考慮する。
- ⑦ 受けた被害については、医師が、患者や患者家族に説明する。

▶記録を残す

- ① 心身への影響が軽微である場合も、言われたこと、されたことの事実を診療録に記録する。
- ② 心身に強い影響を及ぼした重大な事象の場合は、診療録に記録した上で、速やかにインシデントレポートでも報告する。
- ③ 何れの場合も、所属長に速やかに報告を行うが、所属長は、危険行為が繰返されていたり、危険度が増したと判断した場合は、それらをまとめてインシデントレポートで報告する。

▶病院としての対応

- ・インシデントレポートをもとに、医療安全管理室が聞き取りを行い、直近の医療安全カンファレンス（毎週火曜日）にて今後の方針を協議する。

緊急度が高い事案は、院長の判断のもと、医療安全カンファレンスのメンバーと、患者の主治医・被害を受けた部署の所属長を緊急招集し、臨時の医療安全カンファレンスを開催する。

協議内容は

- ① 患者や患者家族への対応（強制退院を含む）
 - ② 被害者への対応（心身サポート、休養・軽作業等の勤務上の配慮、労災対応等）
- ・場合により、警察や弁護士等との連携も行う。
 - ・必要に応じて、所属長は「入院受け入れ拒否患者の申請書」を作成し、患者の今後について協議する。患者が「入院受け入れ拒否患者」に認定されたら、医療安全管理室が手順に沿って院内に周知する。